

Université Constantine 3.
Faculté de médecine.
Département de médecine.
Enseignement 3ème année médecine.
Année universitaire 2024-2025.

Sémiologie de l'appareil digestif

Les objectifs pédagogiques :

- ✓ Maitriser les bases de l'interrogatoire digestif
- ✓ Réaliser un examen physique complet et rigoureux de l'abdomen
- ✓ Distinguer les signes d'orientation topographique

Introduction

Le but l'examen clinique est de trouver des signes cliniques objectifs permettant d'aboutir ou de suspecter un diagnostic correct.

L'examen clinique doit être complet et comprendra

Un interrogatoire ; examen physique de l'abdomen et des autres appareils.

L'interrogatoire

On doit préciser l'origine, la profession et les antécédents personnels du patient aussi bien :

- Médicaux, chirurgicaux, gynécologiques que toxiques.
- Antécédents familiaux.
- On doit analyser les signes fonctionnels digestifs ou extra digestifs et ceci en écoutant le patient, mais aussi en lui posant des questions bien précises

Pour chaque signe, on précisera avec détail ses caractères : la date de survenue, le mode de début, (évolution et les signes associés...

L'examen digestif : comporte trois temps principaux :

- L'examen de la cavité buccale,
- L'examen abdominal,
- L'examen de la marge anale et le toucher rectal.

L'examen de la bouche

Comprend l'examen des dents, des gencives, de la langue, de la muqueuse buccale et de la gorge.

1) les dents: 32 » adulte, 20 » enfant.

- On précise le nombre de caries
- On examine la gencive: ulcération, inflammation, hémorragie (gingivorragie).

2) la langue, et le plancher de la bouche:

L'examen doit se faire à l'aide d'une lampe et d'un abaisse- langue.
On regardera particulièrement l'état :

La langue: pouvant être caractérisée de :

- Normale : recouverte de papilles, humide et rosée,
- Saburrale ou blanche: maladies infectieuses.
- Sèche ou rôtie: déshydratation.
- Lisse, vernissée, dépaillée (glossite s'accompagnant de Brûlures au contact des mets épicés ou acides: anémies (Carence en facteurs antipernicieux) vit B12, acide folique.
- Lisse, luisante et rouge :cirrhose
- Epaisse augmentée de volume: macroglossie; hypothyroïdie , amylose
- Turgescence avec empreinte des dents visible sur les bords: hyperhydratation intracellulaire.

b) Le plancher de la bouche:

le bout de la langue contre la voûte du palais, on observe la face inférieure de la langue avec ses veines proéminentes, le frein, et le plancher de la bouche.

La muqueuse de la face inférieure et du plancher est normalement rose et humide ; de chaque côté du frein se trouve l'orifice des glandes sous-maxillaires.

3) la muqueuse buccale :

La face interne des joues, rosée et humide.

Anomalies:

- Sèche: signe de grande valeur de déshydratation intracellulaire.
- Rouge: inflammatoire, parsemée de petits points blanchâtres :signe de Koplick: énanthème de la rougeole.
- Taches pigmentaires: bleu ardoisé; Addison.
- Inflammatoires; rouge vif: angine érythémateuse.
- Rouge et parsemée d'éléments blancs: angine érythémateux-pultacée
- Recouverte de fausses membranes: rougeur diffuse et pellicules blanchâtres ou grises: angine diphtérique.

Examen de l'abdomen

Temps fondamental de l'examen clinique:

- Inspection palpation percussion auscultation
- Malade détendu, rassuré (respiration calme), pièce correctement éclairée et chauffée
 - Hypochondre droit: bord inférieur du foie, VB, angle CDT.
 - Epigastre: estomac, bulbe duodénal, pancréas, aorte abdominale.
 - Hypochondre gauche: estomac, queue du pancréas, angle colique gauche.
 - Flanc droit: colon ascendant, uretère.
 - Région ombilicale: intestin grêle, aorte abdominale à sa bifurcation.
 - Flanc gauche: colon descendant, uretère gauche.
 - Fosse iliaque droite: caecum, appendice, annexes chez la femme.
 - Région hypogastrique: vessie, utérus.
 - Fosse iliaque gauche: sigmoïde, annexes.

Condition de l'examen clinique

- Malade en décubitus dorsal
- Dêvêtu, tête reposant sur le plan du lit.

- Membres inférieurs légèrement fléchis
- Membres supérieurs allongés le long du corps, ou sur le thorax, sur un lit résistant
- Médecin : à droite du malade, mains réchauffées.
- Ne jamais commencer l'examen par la zone douloureuse

Inspection

- L'état des téguments : La peau de l'abdomen a le même aspect que le reste du corps.
- Cicatrices chirurgicales (motif de l'intervention) traumatiques
- Vergetures :
 - stries blanchâtres (amaigrissement après un surpoids important ; grossesses)
 - roses violacées si hypercorticisme

L'aspect morphologique

- **Forme de l'abdomen:** selon le morphotype du sujet longiligne ou bréviligne.

Distendu:

- Hypertrophie du pannicule adipeux
- Ascite de grande abondance avec ombilic déplissé
- Météorisme abdominal ou distension gazeuse des anses intestinales et du colon
- **LES MOUVEMENTS DE L'ABDOMEN**
- La paroi abdominale est mobile lors de la respiration de façon symétrique, des mouvements anormaux peuvent s'observer:
- Des pulsations au niveau de l'épigastre: syndrome de l'aorte battante.
- Tuméfaction apparaissant lors des efforts ou de la toux: hernie.

Palpation

Étape essentielle mais difficile:

- Superficielle et profonde, douce et prolongée.
- Palper l'abdomen avec les deux mains posées à plat, avec la pulpe des doigts.
- Palper en premier la région la plus éloignée du point douloureux, en parlant au malade.

- Mobiliser le malade en décubitus latéral droit ou gauche, notamment lors de la palpation profonde
- La palpation apprécie:
- le tonus de la paroi,
- et recherche le bord inférieur du foie
- À l'état pathologique la palpation peut mettre en évidence:
- Des modifications du tonus de la paroi abd.
- Hypertrophie d'un viscère ou une tumeur.
- L'existence de points douloureux particuliers.
- La présence d'une hernie.

1) Les modifications du tonus: souvent dues à une atteinte inflammatoire d'un viscère

- intra-abdominal ou une irritation du péritoine:

La défense pariétale:

Diminution de la souplesse de la paroi, le plus souvent localisée en regard d'un foyer inflammatoire, exemple : appendicite aiguë : défense de FID. Doit être différenciée d'une contraction volontaire des muscles due à la nervosité ou à la crainte du patient

La contracture abdominale :

- Contraction invincible des muscles abdominaux qui sont tendus et rigides
- : ((ventre de bois)), elle augmente si on cherche à la vaincre, due à une irritation du péritoine: péritonite; perforation d'un ulcère gastroduodénal.

2) Palpation d'un viscère hypertrophié ou d'une masse tumorale:

- Hépatomégalie: on doit apprécier la consistance du bord inférieur, l'aspect de la surface (régulière ou irrégulière), la consistance et la sensibilité.
 - Vésicule palpable: tuméfaction rénitente de 6 à 8cm de hauteur mobile avec la respiration solidaire du bord inférieur du foie.
- Recherche d'une masse tumorale: Siège , la taille, la forme , la consistance, l'aspect de la surface ,la mobilité et la sensibilité.

3) Recherche de l'existence d'une douleur provoquée et de points douloureux particuliers.

- ❖ La palpation peut exacerber une douleur spontanée ou déclencher une douleur dite provoquée.

4) La recherche d'une hernie:

possède les caractères communs: tuméfaction molle, impulsive à la toux et réductible.

Il faut faire tousser le malade; cette manœuvre :

- augmente la pression abdominale
- fait produire une saillie brusque = la hernie.

LA PERCUSSION

- Doit être douce c'est une percussion médiate elle permet:
- Chez le sujet normal: déterminer la limite sup de la matité hépatique sur la ligne medio claviculaire droite qui correspond au bord sup du foie (5^{ème} EICD), par ailleurs l'abdomen est normalement sonore.
 - Les anomalies:
- Disparition de la matité hépatique : perforation d'ulcère .
- Existence de matités anormales:
- ascite: matité décline à limite sup concave vers le haut, mobile.
- Globe vésical: matité hypogastrique à limite sup convexe vers le haut, très sensible.

Auscultation

- apporte peu de renseignements:

Bruits hydro-aériques de l'intestin: gargouillement caractéristiques du

péristaltisme

- Silence auscultatoire : occlusion intestinale aigue.

- Souffle : en cas de tumeur hyper vascularisée, sténose artérielle, anévrysme

Examen anal et toucher rectal

- **Examen soigneux de la marge anale ;Recherche**
- lésions cutanées
- Fistule: orifice faisant communiquer la marge anale avec le rectum.
- fissure : ulcération linéaire très douloureuse située dans un pli radie de l'an.
- Hémorroïdes externe: varices ano-rectales.
 - Décubitus latéral gauche cuisses et genoux fléchis : permet la recherche d'une tumeur intra rectale: face latérale et postérieure du rectum
S'aider de la palpation abdominale combinée
 - Position genu-pectorale: le malade est à genou ;les épaules et la tête reposant sur la table d'examen; permet d'apprécier le volume de la prostate.
Technique: index recouvert d'un doigtier lubrifié est appliqué sur le sphincter anal qui se relâche, le doigt est introduit dans le canal anal et le rectum.
- Tonicité et sensibilité du canal anal
- Etat de la paroi rectale
- Contenu intra rectal : le doit palpe la paroi latérale et postérieure à la recherche de Tumeur, polype.
- On palpe ensuite la paroi antérieure chez l'homme afin d'évaluer le volume, la forme et la consistance de la prostate, chez la femme le col utérin est palpé sous forme d'une petite masse ronde.
- Cul de sac de Douglas :- Douleur - Comblement

- On demande au malade de pousser ce qui fait descendre le rectum de 7 à 10 cm et permet d'explorer cette partie. Au retrait du doigtier, on note l'aspect des selles : -Glaires -Sang
- Les hémorroïdes internes ne sont pas mises en évidence au toucher rectal, sauf si elles sont thrombosées

conclusion

- l'examen clinique est primordial, il permet non seulement d'orienter le diagnostic mais aussi de choisir de façon judicieuse les examens complémentaires nécessaires; l'interrogatoire doit souvent être directif pour être efficace.

Dr Merzougui. A.I